

« Le patient indésirable »

Travail de fin d'études présenté
pour l'obtention du grade académique de
Bachelier : Infirmier Responsable de soins généraux
par

LOREAUX Valérie
Juin 2025

Remerciements

Je tiens à remercier mes deux promotrices, madame Maucq et madame Halin, pour leurs conseils, leurs encouragements, leur disponibilité et leur soutien. Merci de m'avoir poussée dans mes réflexions afin de rendre ce travail plus riche.

Merci aux équipes infirmières de La Petite Plante, de la Fondation Autisme Luxembourg, du Centre Thérapeutique d'Useldange CHNP ainsi que le service addictologie W2 de la Zithaklinik des Hôpitaux Robert Schuman pour leur accueil et tout ce qu'elles m'ont appris cette année.

Pour terminer, un énorme merci à Antoine, Elisabeth, Faustine et toute ma famille. Promis, je ne fais pas le master (pas tout de suite).

Ce travail est dédié à monsieur R., madame H. et monsieur B.

Mots- clés :

Patient indésirable

Equité

Paradigme

Table des matières

Introduction	5
1. Constats, interpellations et ancrage à la discipline infirmière	6
1.1. Constats et interpellations.....	6
1.2. L’ancrage	11
1.2.1. Cadre légal, déontologique et professionnel	11
2. Recherches et réflexion professionnalisante	17
2.1. Le patient indésirable.....	17
2.2. Analyse de l’article probant.....	25
2.3. Enquête exploratoire.....	29
3. Synthèse, conclusion du travail et pistes de réflexion.....	34
Conclusion personnelle	36
Liste de références.....	37

Introduction

Lorsque j'ai commencé mes études à la Haute École Robert Schuman (HERS), j'avais une vision bien précise de l'infirmière que je voulais devenir. Je me rêvais compétente, bienveillante, patiente. La « bonne infirmière » : celle qui ne soupire jamais en entendant une sonnette, celle qui ne lève jamais les yeux au ciel face au patient diabétique qui mange des bonbons, celle qui ne juge jamais.

Mais ce qu'on ne nous apprend pas dans la théorie, c'est qu'un jour, un patient va venir bousculer ces belles intentions. Un patient qui va nous mettre à l'épreuve, nous tester, nous exaspérer. Un patient qui, en défiant nos attentes, risque de réveiller en nous une part d'agacement. Un patient qui va nous amener à penser l'impensable : « Pourquoi devrais-je m'investir autant pour lui ? ».

Le patient indésirable n'existe pas dans les textes de loi. Officiellement, nous devons soigner chacun avec la même attention, la même qualité de soins. Pourtant, dans la réalité du terrain, certains patients sont étiquetés différemment. Trop exigeants, trop irresponsables, trop difficiles. Ces patients qui compliquent notre travail et qui nous renvoient à nos propres limites. Et face à eux, l'image de la bonne infirmière que l'on rêvait d'être peut vaciller.

Ce travail de fin d'études est né de cette interrogation. Pourquoi certains patients deviennent-ils « indésirables » aux yeux des soignants ? Comment la relation de soin peut-elle basculer vers le jugement ? Et surtout, comment concilier notre engagement d'infirmière avec ces situations qui nous confrontent à nos propres contradictions ?

Ce travail de fin d'études s'articule en trois parties. Tout d'abord, je présenterai trois situations concrètes vécues lors de mes stages qui m'ont interpellée et qui ont donné naissance à ma réflexion. Ensuite, j'explorerai le cadre théorique, légal et déontologique qui entoure cette problématique afin d'éclairer les enjeux liés aux jugements et aux comportements infirmiers face à ces patients particuliers. Je continuerai ma réflexion en approfondissant le concept central du « patient indésirable » à travers l'analyse d'un article probant et les données issues d'une enquête exploratoire menée auprès de deux infirmiers de terrain. Je terminerai en ouvrant une réflexion professionnelle et en proposant une synthèse de l'ensemble du travail réalisé.

1. Constats, interpellations et ancrage à la discipline infirmière

1.1. Constats et interpellations

- Premier constat :

Durant ma troisième année de formation en bachelier infirmier responsable de soins généraux, trois situations m'ont incitée à choisir le thème que j'ai décidé d'approfondir dans ce travail de fin d'études.

La première situation s'est déroulée en octobre 2023 durant mon stage en cardiologie. Pendant la transmission du dimanche matin, l'infirmier de nuit a annoncé qu'un patient avait été admis dans le service aux petites heures du matin pour une fibrillation auriculaire paroxystique. Ce patient s'était présenté aux urgences en état d'ébriété où il avait été pris en charge quelques heures avant d'être transféré dans le service. Son rythme cardiaque demeurait irrégulier, nécessitant un bilan afin de le remettre en rythme sinusal. Lors de l'annonce de l'identité du patient, monsieur R., les infirmières présentes ont tout de suite réagi en soupirant et en levant les yeux au ciel « *pas encore lui !* » (*dixit*). Face à mon étonnement devant leur réaction, l'infirmier m'a expliqué que ce patient, monsieur R., était connu du service pour des hospitalisations régulières dues à des épisodes de fibrillation auriculaire paroxystique, déclenchés par une consommation d'alcool excessive lors de soirées festives. Après la transmission, j'ai été affectée au secteur dans lequel monsieur R. était hospitalisé. Durant la matinée, je suis entrée deux fois dans sa chambre pour y déposer son plateau repas et prendre ses paramètres mais il n'était pas présent. Le patient était perfusé depuis son admission, recevant un traitement antiarythmique par voie intraveineuse pour traiter sa fibrillation auriculaire. Il était indispensable que sa perfusion coule correctement afin de rétablir son rythme sinusal et d'éviter un choc électrique externe. Étonnée par son absence, j'ai interrogé l'infirmière du secteur. Elle m'a expliqué que monsieur R. fumait environ quinze cigarettes par jour et avait une nouvelle fois refusé la proposition de sevrage tabagique. Il descendait donc en moyenne une fois par heure en journée au fumoir situé à l'entrée de l'hôpital. Il était souvent absent de sa chambre au moment des tours de paramètres, de la distribution des médicaments ou encore du passage du médecin. Juste avant la distribution des repas de midi, alors que je venais de croiser monsieur R. de retour dans les couloirs, ce dernier sonne car il avait mal à son point de ponction depuis son retour en chambre. Après vérification, j'ai constaté que le cathéter n'était plus dans

la veine. J'ai arrêté la perfusion et je suis allée prévenir l'infirmière qui a réagi immédiatement : « *Non, non et non, c'est toujours la même chose avec lui. Je n'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un qui ne veut pas se prendre en main. Il a le temps d'aller fumer sa cigarette ? Il aura le temps d'attendre que je termine de m'occuper des gens qui veulent vraiment se soigner* » (dixit). Après cette réponse, l'infirmière a poursuivi son tour de distribution des médicaments dans les autres chambres. Ce n'est qu'environ trente minutes plus tard qu'elle est revenue dans la chambre de monsieur R. pour remettre en place une nouvelle perfusion. Pendant toute cette période, le patient n'a pas reçu son traitement antiarythmique intraveineux, ce qui pouvait potentiellement retarder le rétablissement de son rythme sinusal.

- Première interpellation :

Cette situation m'a interpellée sur trois aspects. Premièrement, le sentiment d'exaspération unanimement exprimé par l'équipe lors de l'annonce du retour de monsieur R. : les infirmières présentes ont soufflé, levé les yeux au ciel, et certaines ont dit « *pas encore lui* ». Deuxièmement, j'ai été interpellée par l'attitude de monsieur R. concernant son choix de ne pas modifier ses comportements néfastes pour sa santé et de continuer à fumer et à consommer de l'alcool bien que cela entraîne des hospitalisations répétées. Enfin, j'ai été interpellée par la vive réaction de l'infirmière envers monsieur R. et sa décision de retarder la perfusion. Elle semble juger qu'il ne veut pas se soigner, notamment parce qu'il refuse le sevrage tabagique proposé par l'équipe. Ce refus de sevrage complique l'organisation de sa prise en charge pour les soignants en raison de ses absences répétées pour aller fumer sa quinzaine de cigarettes par jour devant l'hôpital. J'ai eu le sentiment qu'elle cherchait à le « punir » en retardant son soin. Elle semble également le comparer aux autres patients qui, eux, « veulent s'en sortir », comme s'il ne méritait dès lors pas qu'on s'occupe prioritairement de lui.

- Deuxième constat :

La deuxième situation s'est présentée en avril 2024, lors de mon stage en chirurgie orthopédique. Madame H., âgée de 73 ans, avait été admise dans le service après une chute survenue dans la maison de repos et de soins où elle séjournait depuis la mort de son mari. La gravité de sa blessure avait nécessité la pose chirurgicale d'une prothèse totale de hanche droite. Madame H., parfaitement lucide, conservait toutes ses facultés mentales et cognitives. Elle comprenait donc parfaitement sa situation médicale et les implications de son opération. Cependant, dès le premier jour post-opératoire, elle a rapidement exprimé sa décision de ne

plus vouloir marcher, invoquant des raisons de sécurité : « *c'est trop dangereux pour moi* » (*dixit*). Elle avait perdu confiance en son équilibre et considérait son poids important, 115 kilos, comme un risque supplémentaire de chute. Lors d'une toilette, j'avais questionné madame H. sur son choix de ne plus se lever, de ne plus marcher. Elle m'avait expliqué qu'elle avait consacré une grande partie de sa vie à s'occuper des autres et qu'elle méritait de se reposer. Elle voulait passer le reste de sa vie alitée, dans sa maison de repos et de soins. Cette décision de la patiente avait étonné l'équipe pluridisciplinaire car le protocole après la pose d'une prothèse totale de hanche est de favoriser un lever et une rééducation précoces. Le kinésithérapeute avait rapidement noté que la jambe opérée avait pris une position vicieuse et exprimait sa crainte que l'absence de mobilisation debout, combinée à cette position incorrecte, n'aggrave la raideur articulaire et n'entraîne une perte musculaire autour de la hanche. Madame H. était très douloureuse lors de chaque manipulation, malgré la prise d'antidouleurs. Sa toilette complète au lit nécessitait la présence de deux soignants, en raison du poids de la patiente et de ses mouvements limités après la pose de la prothèse. Celle-ci contre-indiquait toute flexion excessive de la hanche et rotation interne de la jambe droite. Afin de prévenir les escarres et de mobiliser au maximum ses muscles, Madame était déplacée en lève-personne au fauteuil après sa toilette mais elle sonnait plusieurs fois en matinée pour qu'on la remette au lit. Elle se plaignait quotidiennement de douleurs aux jambes et demandait régulièrement des massages avec sa crème hydratante personnelle, affirmant que cela la soulageait. L'équipe infirmière se plaignait des demandes répétées de massage des jambes de la patiente, exprimant également de l'incompréhension face à son refus de marcher.

Ce jour-là, j'étais en horaire B, le service était complet et la charge de travail conséquente. Nous étions trois : deux infirmières et moi-même. En après-midi, selon les habitudes du service, les infirmières étaient responsables de préparer les médicaments des deux secteurs jusqu'au lendemain matin. J'étais donc chargée de répondre aux sonnettes et d'assurer les retours de bloc pendant leurs préparations des médicaments. Les sonnettes étaient nombreuses et impliquaient souvent des aides aux déplacements vers les sanitaires. Vers 15h, madame H. a sonné et je suis rentrée dans sa chambre. Elle m'a demandé un massage de ses jambes car elle ressentait de fortes douleurs. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas le faire pour l'instant car un patient venait juste de remonter du bloc opératoire et que je devais aller prendre ses paramètres. Une heure et demie plus tard, l'infirmière m'a rejointe dans le secteur. Dans le feu de l'action, j'avais complètement oublié la demande de madame H. Soudain, la sonnette de sa chambre s'alluma. L'infirmière s'est alors tournée vers moi : « *on va y aller à deux au cas où il faudrait la*

changer » (dixit). Alors que je rentrais en première dans la chambre de madame H., celle-ci semblait énervée, réexprimant sa douleur importante aux jambes et nous redemandant un massage pour la soulager. L'infirmière a alors dit "Vous savez, madame H., si vous n'aviez pas décidé de ne plus marcher, peut-être que vous n'auriez pas autant de douleur maintenant. Je suis désolée, mais nous n'avons vraiment pas le temps de répondre à votre demande" (dixit). Je vis son expression se figer et nous sommes sorties de la chambre.

À cet instant, j'ai pris conscience que les paroles de l'infirmière reflétaient également mon propre ressenti. Le refus de la patiente de suivre la rééducation recommandée provoquait en moi un sentiment d'incompréhension et d'injustice. Sa prise en charge nécessitait déjà beaucoup de temps et de soins, et je trouvais injuste de lui accorder plus d'attention qu'aux autres patients. Chaque nouvelle demande de sa part me rappelait ce déséquilibre, renforçant mon jugement de valeur à son égard.

○ Deuxième interpellation :

Cette deuxième situation de stage m'a interpellée sur plusieurs points. Premièrement, j'ai été interpellée par le choix de madame H. concernant sa santé : sa décision de ne plus vouloir marcher, estimant qu'elle méritait de se reposer et de passer le reste de sa vie alitée dans sa maison de repos et de soins. Deuxièmement, j'ai constaté l'impact de sa décision sur la charge de travail : ses soins au lit mobilisaient systématiquement deux personnes en raison de ses douleurs et de son poids. Même levée pour prévenir les escarres, elle demandait souvent de retourner dans son lit. Ses demandes récurrentes (massages, soins spécifiques) prolongeaient considérablement le temps qui lui était consacré, bien au-delà de ce qui est habituel dans le service pour un patient au même stade post-opératoire. Troisièmement, j'ai été interpellée par la réaction de l'équipe infirmière envers cette patiente, réaction à laquelle j'ai moi-même pris part. Les demandes de soins de madame H. pour soulager sa douleur, comme les massages, étaient perçues par les soignants comme moins importantes et moins prioritaires car ils jugeaient que sa douleur résultait de sa propre décision de ne plus marcher. L'infirmière lui a d'ailleurs dit : *"Vous savez, madame H., si vous n'aviez pas décidé de ne plus marcher, peut-être que vous n'auriez pas autant de douleur maintenant"* (dixit), illustrant le sentiment qu'elle « méritait » moins d'attention et de soins qu'un patient qui aurait suivi la rééducation. J'ai été interpellée par le fait que nous pensions qu'une patiente ne méritait pas que nous prenions soin de sa douleur parce qu'elle subissait simplement les conséquences de sa propre décision, laquelle entraînait également plus de travail pour nous.

- Troisième constat :

Ces deux situations m'ont amenée, par contraste, à repenser à mon stage en psychiatrie, dans un service d'addictologie, qui s'était déroulé en début d'année scolaire. Durant ces trois semaines, j'avais côtoyé de nombreux patients qui revenaient fréquemment après des périodes d'abstinence non maintenues, nécessitant à chaque fois une nouvelle prise en charge pour le sevrage et le traitement des complications liées à leur addiction. L'équipe soignante prenait en charge ces patients, sans jugement sur la récurrence de leurs hospitalisations ou leurs choix de vie. Lors de ce stage, l'un des patients de l'unité, monsieur B., diagnostiqué schizophrène depuis son adolescence, avait refusé son injection intramusculaire d'antipsychotique à longue durée d'action, essentielle pour stabiliser son état. Après avoir longuement discuté avec lui des conséquences de ce refus sur sa santé, l'équipe infirmière avait simplement noté son objection sans émettre de jugement. Les infirmiers n'avaient pas modifié leurs attitudes à l'égard du patient après ce refus, même si cette décision compliquait la prise en charge de son sevrage et allait à l'encontre des recommandations médicales.

- Troisième interpellation :

Dans cette situation, j'ai été interpellée par la décision de monsieur B. de refuser une injection prescrite pour stabiliser sa schizophrénie, et ce malgré les explications des infirmiers. J'ai également été interpellée par l'attitude de l'équipe infirmière. Cette dernière a respecté la décision du patient et n'a pas modifié sa manière de prendre monsieur B. en charge après son refus de traitement. Contrairement aux deux situations précédentes, monsieur B. n'a pas été considéré comme moins méritant en raison de son comportement à risque pour sa santé, même si ce dernier compliquait sa prise en charge et allait à l'encontre des recommandations médicales.

Interpellation provisoire commune aux trois constats

Dès lors, je suis interpellée par le fait que lorsque des patients hospitalisés ont des comportements préjudiciables pour leur santé, reflétant un manque de motivation pour améliorer leur état ou perturbateurs de l'organisation des soins du service, ils peuvent être jugés comme des « mauvais patients ». Les infirmiers semblent alors accorder moins d'attention à ces patients qu'ils jugent « moins méritants », privilégiant les « bons » patients qui correspondent à leurs attentes. Cette perception conduit à des refus ou des retards dans la prestation de certains soins essentiels.

1.2. L'ancrage

Pour mieux comprendre ces situations et les interrogations qu'elles soulèvent, je vais maintenant examiner mon interpellation à la lumière des textes législatifs et réglementaires qui encadrent la profession infirmière en Belgique, ainsi que des normes professionnelles définies dans le référentiel de compétences du bachelier infirmier responsable de soins généraux de la HERS.

1.2.1. Cadre légal, déontologique et professionnel

Dans cette perspective, je m'interroge d'abord sur l'attitude des infirmiers dans les deux premiers constats : ont-ils le droit de distinguer certains patients comme « mauvais », c'est-à-dire « moins méritants » et d'autres comme « bons » c'est-à-dire « plus méritants » ?

Pour apporter un premier éclairage, je me tourne vers la loi relative aux droits du patient du 22 août 2002, modifiée par la loi du 6 février 2024, qui mentionne dans son chapitre 3 (Droits du patient), article 5 :

Le patient a droit, de la part du professionnel des soins de santé, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite. Le professionnel des soins de santé respecte la dignité humaine et l'autonomie du patient et tient compte des objectifs et des valeurs de ce dernier (Le moniteur Belge, 23 février 2024, p.26663).

Cet article met l'accent sur l'interdiction de toute forme de distinction à l'encontre des patients. Cette exigence est également présente dans le Code de déontologie des praticiens de l'art infirmier belges, article 1 : « L'infirmier prodigue ses soins de façon équivalente à tous les bénéficiaires, sans discrimination (...) de style de vie. » (Le conseil de l'art infirmier, 2018, p.3).

Dans le référentiel de la HERS, le respect de la législation et du code de déontologie sont mentionnés dans la compétence 2, « Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires ». Les capacités décrites au sein de cette compétence sont celles d'appliquer « les droits du patient selon la loi du 22 août 2002 aux situations de terrain » et de dispenser leurs soins « dans le respect du code de Déontologie des praticiens de l'art infirmier belge » (HERS, 2020-2021, pp.7-8).

La loi, le code de déontologie et le référentiel de compétence de la HERS sont clairs sur l'exigence d'une application uniforme, c'est-à-dire sans distinction, des principes fondamentaux des soins infirmiers, indépendamment des caractéristiques personnelles, sociales ou culturelles des patients.

Pourtant, dans les situations observées, les infirmiers semblent avoir différencié leur prise en charge en fonction de jugements personnels portant sur le comportement des patients. En effet, le comportement de monsieur R. et de madame H. a suscité l'étiquetage de « mauvais patients », en opposition à ceux considérés comme « bons » parce qu'ils se conforment aux recommandations et attentes de l'équipe soignante. Mais comment qualifier la nature de cette distinction ? Qualifier un patient de « bon » ou de « mauvais » repose sur un jugement de valeur qui, selon Maggiori (2013, paragr.1), « met en jeu des conceptions, sinon des sensations ou des émotions, dont on dit immédiatement qu'elles diffèrent d'un individu à un autre ». Plus précisément, il s'agit d'un jugement moral, c'est-à-dire d'une évaluation subjective visant à déterminer si une action ou un comportement est conforme aux valeurs de bien ou de mal d'une société ou d'un individu et qui peut parfois se révéler plus spontané, « dans la mesure où il découle non pas tant de la raison que du sentiment » (Bachler, 2013, p.218). L'une des capacités décrites dans le référentiel de la HERS illustre directement la problématique du jugement moral. Dans la compétence 5, « Assurer une communication professionnelle », la capacité 5.3 souligne l'importance d'« établir avec l'individu sain ou malade, son entourage et/ou la collectivité une relation adaptée au contexte rencontré ». Plus précisément, le point d) insiste sur la nécessité de « gérer ses réactions émotionnelles » et de « discerner les émotions des jugements et des faits » (HERS, 2020-2021, p.20). Ainsi, l'infirmier doit être en mesure de différencier ses propres réactions émotionnelles de l'évaluation objective du comportement du patient, afin d'éviter que ses sentiments personnels n'influencent sa prise en charge.

Dans la continuité de cette réflexion autour du jugement moral et de la nécessité de distinguer émotions et faits, il me semble dès lors essentiel de s'interroger sur l'existence d'un cadre légal encadrant spécifiquement la prise de décision des soignants. Peut-on prendre des décisions de soins basées sur un jugement moral ? Mes recherches m'ont amenée à la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé du 22 avril 2019, modifiée par la loi du 18 mai 2024, qui stipule, dans son chapitre 3 (Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé), article 4 :

Le professionnel des soins de santé choisit librement, dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi, les moyens qu'il met en œuvre dans le cadre de la prestation de soins de santé. (...). Le professionnel des soins de santé se laisse guider, dans son choix (...), par des données scientifiques pertinentes et son expertise, tout en tenant compte des préférences du patient (Le moniteur Belge, 31 mai 2024, p.46373).

A la lecture de cet article, je constate que le législateur est clair : les décisions prises par les infirmiers dans le cadre de leur prestation de soins de santé doivent s'appuyer sur des données scientifiques objectives. Or, cela n'a pas été le cas dans les prises en charge de monsieur R. et madame H. Les soins ont été modifiés en fonction de critères subjectifs, ce qui revient à appliquer un « traitement inégal reposant sur l'application d'un critère illégitime », inscrivant ainsi la prise en charge dans une logique discriminatoire (Lochak, 1987, p.778).

Cette discrimination, dans mes constats, se traduit par des refus ou des retards dans la prestation de certains soins essentiels, c'est-à-dire d'une diminution de la qualité des soins infirmiers.

Or, l'importance pour le professionnel des soins de santé de donner au patient « des prestations de qualité » est mentionnée dans la loi relative aux droits du patient du 22 août 2002 (Le moniteur Belge, 23 février 2024, p.26663). Cette exigence de qualité est également reprise à l'article 46 de la loi coordonnée relative aux professions des soins de santé du 10 mai 2015, modifiée par la loi du 18 mai 2024, précise dans son article 46 :

Les soins infirmiers tiennent compte (...) des normes de qualité et de la déontologie professionnelle (Le moniteur Belge, 30 mai 2024, p. 68211).

Comment, dès lors, définir précisément des soins de qualité ? L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) propose la définition suivante : « pour être de qualité, les services de santé doivent être efficaces, sûrs, centrés sur la personne, disponibles en temps opportun (...) et équitables » (OMS, 2020, paragr.2).

Parmi ces critères, le caractère « équitable » revêt une importance particulière dans le contexte de mon interpellation. Le Petit Larousse Illustré définit « équitable » comme ce qui est « conforme à l'équité » (2022, p.433). Néanmoins, le concept d'équité en santé demeure complexe. Bodenmann et al. soulignent en effet qu'il n'existe pas de définition simple et unique de l'« équité en santé », mais plutôt « trois dimensions opérationnelles ... : l'équité clinique, institutionnelle et structurelle » (2023, p.1295). Les auteurs expliquent que l'équité

institutionnelle concerne l'adaptation des structures de soins aux capacités et aux besoins des patients, tandis que l'équité structurelle se rapporte à des changements sociétaux, tels que les politiques de santé (2023, p.1296). Ces deux dimensions dépassent le cadre de ce travail car elles relèvent de l'organisation ou de la politique de santé dans son ensemble, et non de la relation entre le soignant et patient. Dans le cadre de mon interpellation, c'est donc l'équité clinique qui m'intéresse particulièrement car, dans la théorie en tout cas, elle amène le clinicien « à faire plus pour le patient de droite que pour les deux autres ; il s'adapte aux besoins spécifiques de chacun en tenant compte des différences dans les déterminants socio-économiques, environnementaux et culturels de la santé et de la maladie. » (Bodenmann et al., 2023, p.1295).

Et pourtant, dans les situations de monsieur R. et madame H., les infirmiers n'ont pas appliqué cette approche puisqu'ils n'ont pas adapté leurs prises en charge aux besoins spécifiques de ces deux patients.

Ainsi, bien que la législation et les référentiels professionnels imposent une prise en charge équitable et fondée sur des critères objectifs, les observations issues de mes situations de stage montrent que certains patients reçoivent des soins différenciés en fonction de jugements subjectifs.

Pour mieux comprendre ce phénomène, je souhaite maintenant analyser et définir les caractéristiques des patients concernés, c'est-à-dire monsieur R., madame H. et monsieur B.

Les trois patients observés dans mes constats présentent des caractéristiques correspondant à deux diagnostics infirmiers établis par la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) :

1. **Le « comportement à risque pour la santé »** : caractérisé par l'« incapacité de modifier ses habitudes de vie et/ou ses actions de manière à pouvoir améliorer son niveau de bien-être » (NANDA International, 2021, p. 219-220).
2. **L' « absence de motivation à améliorer l'autogestion de la santé »** : traduisant un « manque de désir d'intégrer le programme thérapeutique ou de changer son mode de vie en faveur de la santé » (NANDA International, 2021, p. 225).

Cependant, bien que ces trois patients partagent ces caractéristiques, seuls Monsieur R. et Madame H. ont été considérés comme des « mauvais » patients par l'équipe soignante, tandis que Monsieur B., hospitalisé en psychiatrie, a bénéficié d'une prise en charge équitable, malgré

son refus de traitement. Cette distinction révèle un élément essentiel : ce n'est pas tant le comportement du patient qui suscite le jugement, mais la manière dont il est perçu par les soignants.

Dès lors, comment nommer ces patients qui ne correspondent pas aux attentes des soignants et qui, par leurs comportements, suscitent incompréhension, frustration ou même exaspération ? Ce profil est-il déjà documenté dans la littérature scientifique ?

Mes premières recherches m'ont d'abord conduit vers le concept de patient difficile, couramment évoqué dans la littérature médicale pour désigner les patients qui suscitent des émotions négatives chez les soignants. Un « patient difficile » se caractérise par des comportements précis, tels qu'une tendance à systématiquement contester les diagnostics, un refus de coopération dans les soins ou même un ensemble de symptômes résistants aux traitements [traduction libre] (Fiester, 2012, p.3). Un concept voisin, celui de « *heartsink* » patient, est utilisé pour décrire des patients qui suscitent chez le praticien un accablant mélange d'exaspération, de défaite et parfois de simple aversion qui occasionne de l'angoisse. Lorsque ces patients « *heartsink* » consultent, le praticien sent son cœur qui se noie car leur prise en charge est impossible, souvent dû à des plaintes récurrentes ou à l'absence de solution médicale évidente [traduction libre] (O'Dowd, 1988, p.528).

Ces deux types de patients posent des défis complexes qui sont donc inhérents à leur état de santé ou à leur attitude vis-à-vis du soignant, rendant leur prise en charge médicalement ou relationnellement problématique.

Or, dans mes observations de stage, monsieur R., madame H. et monsieur B. ne correspondent pas à ces définitions. Leur prise en charge n'était pas impossible ni particulièrement complexe sur le plan médical. Ce qui a provoqué des tensions ne relève pas d'une impasse clinique, mais bien de la perception des soignants vis-à-vis de leurs comportements. Autrement dit, le malaise ressenti par les infirmiers ne venait pas d'une difficulté objective à soigner ces patients, mais plutôt d'un sentiment de frustration et d'exaspération face à leurs comportements.

Afin d'explorer cette dimension subjective, j'ai poursuivi mes recherches et je me suis orientée vers un autre concept, apparu dans la littérature médicale francophone au début des années 2000 : celui du « patient indésirable », qui éclaire avec force la dynamique que j'ai pu observer

dans mes constats. L'étymologie du terme permet de mieux comprendre son sens (Académie française, s.d.) :

- Le mot « patient », issu du latin *patiens*, désigne « celui qui endure » ou « celui qui souffre ».
- L'adjectif « indésirable », apparu au XIX^e siècle, renvoie à une personne dont la présence n'est pas souhaitée.

L'association de ces deux termes souligne un paradoxe : le patient est censé être accueilli et pris en charge, mais il devient ici une présence perçue comme dérangeante. Contrairement aux concepts du « patient difficile » et du « heartsink patient », « le patient indésirable » n'est pas défini par des critères cliniques fixes, mais par une perception propre à chaque infirmier et à chaque contexte de soins. Comme le définit Longneaux, « le patient indésirable n'est pas identifiable à une pathologie particulière ou à un profil singulier... un patient n'est jamais indésirable par lui-même, il l'est toujours pour quelqu'un » (2005, p.2). Chaque soignant a ainsi « ses patients non désirés selon son vécu, son mode de vie, sa mentalité, sa culture... » (Laurent et al., 2005, p.38). Serano confirme cette idée en expliquant que ce concept se construit « par effet et non par essence », soulignant qu'il n'existe pas de « liste » ni de « critères définis » permettant d'identifier un patient indésirable, car cette idée « peut facilement varier d'une personne à l'autre selon le vécu, l'expérience et les idéologies personnelles » (2005, p.47). C'est précisément ce qui ressort des expériences vécues auprès de monsieur R. et de madame H. : le concept de « patient indésirable » souligne que le problème réside moins dans le comportement du patient que dans la manière dont ce dernier est perçu et vécu par le soignant. A l'issue de ces recherches théoriques, professionnelles et législatives, je peux désormais définir de manière plus précise mon interpellation finale.

Interpellation finale

Je suis interpellée par le fait que certains infirmiers peuvent juger des patients hospitalisés comme « indésirables » en raison de leur comportement à risque pour leur santé, de leur absence de motivation à améliorer leur état ou leurs comportements jugés perturbateurs pour l'organisation du service. Ce jugement moral, dénué de données scientifiques, devient le critère illégitime sur lequel s'appuie une attitude soignante discriminatoire : le patient est alors distingué comme « moins méritant » et reçoit des soins de moins bonne qualité, notamment une prise en charge qui s'écarte du principe d'équité clinique et qui ne répond pas à ses besoins.

2. Recherches et réflexion professionnalisante

2.1. Le patient indésirable

Dans son éditorial de la revue *Ethica Clinica* consacrée au patient indésirable, Longneaux propose la définition suivante :

On ne dit rien d'autre lorsqu'on constate que le patient indésirable, c'est celui qui ne répond pas à nos attentes, à nos projections, celui qui va au-delà de ce que nous sommes capables de supporter, celui qui grippe les rouages de la « grande machine » qu'est l'institution pour laquelle nous travaillons, nous mettant parfois en porte-à-faux par rapport à nous-mêmes, à nos collègues ou notre direction, quand ce n'est pas par rapport à la loi. Le caractère indésirable de ce patient-là dépendra donc moins d'une caractéristique universellement et objectivement insupportable, que de notre incapacité personnelle, ou institutionnelle, à pouvoir l'assumer, et qui varie d'un individu à l'autre, d'une institution à l'autre (2005, p.2).

Cette définition met en lumière plusieurs attributs du patient indésirable. Tout d'abord, comme nous l'avons souligné précédemment, ce dernier n'est pas lié à un diagnostic ou à un tableau clinique précis. Ensuite, il se caractérise par l'effet jugé « objectivement insupportable » qu'il produit sur le professionnel de santé. Enfin, il naît d'une interaction entre la manière dont le patient se comporte et la façon dont ce comportement est perçu par les soignants. Autrement dit, « le caractère indésirable » naît dans la relation entre le patient et le professionnel de la santé.

Le concept de « relation » est défini par Manoukian et al. comme « une rencontre entre deux personnes au moins, c'est-à-dire deux caractères, deux psychologies particulières et deux histoires ... Au-delà de la relation entre deux personnes, c'est son contexte qui permet à chacun de déduire un sens » (2014, p. 5).

En conséquence, la relation résulte à la fois :

- de la rencontre entre le soignant et le patient
- du sens donné par le contexte dans lequel cette rencontre se déploie

Ainsi, selon Manoukian et al, une rencontre seule ne constitue pas une relation : c'est le sens que chacun lui attribue, en fonction du contexte, qui fait de cette rencontre une relation à proprement parler.

La rencontre entre un professionnel (infirmier, médecin...) et un patient (usager du système de soins) se déroule dans un cadre spécifique : celui des soins de santé. Contrairement aux interactions sociales ordinaires, cette rencontre s'inscrit traditionnellement dans une dynamique où les rôles sont clairement définis. Dès 1955, Talcott Parsons a proposé la notion de « relation thérapeutique asymétrique » pour décrire cette relation :

- Le **soignant** détient un savoir légitimé par ses compétences professionnelles et son expertise. Le sens qu'il donne à la rencontre est de « soigner, apaiser, accompagner le patient dans la maladie » (Nitschelm, 2015, p. 47).
- Le **patient**, pour sa part, se trouve en situation de vulnérabilité et de précarité du fait de sa maladie ou de sa douleur. Il donne du sens à cette rencontre en se rendant momentanément dépendant du professionnel pour rétablir son équilibre (Pierron, 2007, p.44).

Pour Parsons, cette asymétrie est une condition essentielle pour garantir l'efficacité des soins. Le patient, placé en position de demandeur, accepte volontairement une relation où le soignant détient temporairement une forme de pouvoir légitimé par ses compétences (Le Callonnec, 2023, p.264). En théorie, cette configuration vise à assurer une prise en charge optimale, en facilitant une coopération harmonieuse entre soignant et soigné.

Si l'asymétrie structure la relation thérapeutique telle que décrite par Parsons, la profession infirmière reconnaît plus spécifiquement le lien avec le patient comme « un élément central des soins » (Formarier, 2007, p. 33). La « relation de soin » est, selon Formarier, la relation « la plus fréquente en milieu hospitalier ». Elle est « mise en œuvre par le soignant », se caractérise par un mode de communication « essentiellement de type informatif » et constitue un « support d'échanges » avec le patient comme avec sa famille (p.37). Pourtant, cette relation ne s'improvise pas, Formarier précise qu'elle « relève du champ professionnel » et obéit à des normes ainsi qu'à des attentes bien définies. Elle s'inscrit dans « des rapports sociaux codifiés », reposant sur des « pratiques répétitives, voire des scénarii » qui permettent aux

infirmiers d'évoluer dans un environnement à la fois stable et efficace (p. 34). Le sens de cette relation professionnelle repose ainsi sur une forme de coopération implicite : le patient est supposé « adopter les comportements attendus », autrement dit faire preuve de ponctualité, de coopération et adhérer aux recommandations (p. 34). De son côté, l'infirmier veille à maintenir l'organisation et la qualité des soins dans un cadre normatif structurant.

Ainsi, la « relation asymétrique » (plus largement entre soignant et soigné) et la « relation de soin » (plus spécifiquement infirmière) prennent leur sens lorsque le soignant et le patient reconnaissent ensemble le cadre thérapeutique, c'est-à-dire le sens donné à leur rencontre. C'est cette reconnaissance mutuelle qui transforme une interaction ordinaire en une véritable relation de soin. À l'inverse, lorsque le patient refuse d'adhérer au sens donné à la rencontre, la construction d'une relation soignant-soigné devient impossible. Ce type de refus apparaît clairement dans les constats issus de mes stages, où se révèle la notion de patient indésirable :

- Monsieur R. quitte régulièrement sa chambre pour aller fumer, alors que l'équipe souhaite restaurer son rythme cardiaque et assurer un suivi régulier de ses paramètres. Du point de vue soignant, le sens de la rencontre est thérapeutique. Du point de vue de Monsieur R., le besoin immédiat est de fumer. Il rejette donc le sens de la relation de l'équipe soignante, rompant à la fois l'asymétrie (l'autorité légitime du soignant) et la relation de soin (coopération, échange d'informations).
- Madame H. refuse d'adhérer aux recommandations médicales et de réaliser une rééducation, pourtant considérée par l'équipe comme essentielle pour garantir la qualité des soins et prévenir les complications post-opératoires. Ce refus remet en question la relation thérapeutique asymétrique : Madame H. rejette l'autorité légitime du soignant ainsi que le sens donné à la rencontre. Par ailleurs, elle sort des scénarii habituels de la relation de soin en formulant des demandes atypiques pour soulager sa douleur, notamment par des massages. Ne répondant pas aux comportements attendus, elle rompt la coopération implicite qui structure la relation de soin et qui sécurise le cadre professionnel du soignant.

Ces exemples montrent que, si le patient et le soignant ne donnent pas le même sens à leur rencontre, la relation de soin ne peut pas se construire. Le patient, alors en décalage avec les attentes du soignant, devient un « patient indésirable ».

Je m'interroge à présent sur l'origine de cette difficulté à donner un sens commun dans la rencontre entre l'infirmier et le patient indésirable. Selon Manoukian et al. (2014), le sens d'une relation dépend directement du contexte dans lequel elle prend forme. Or, dans ce travail, mes trois constats se déroulent à l'hôpital. Il devient donc essentiel d'examiner plus en détail l'influence que ce contexte hospitalier exerce sur la rencontre soignant-soigné.

Selon Vega (2001, p. 11) :

L'hôpital est une institution particulièrement hiérarchisée (officiellement et officieusement), qui véhicule des représentations, des pratiques et des discours médicaux dominants, souvent imposés aux patients. Lorsque l'attitude de certains soignés s'éloigne des normes des professionnels, elle peut alors susciter de nombreux étiquetages de la part des professionnels.

Cette observation souligne que l'hôpital ne constitue pas uniquement un lieu neutre dédié aux soins ; il s'agit également d'une institution régie par des normes médicales et sociales précises qui déterminent souvent la manière dont les patients doivent se comporter. Autrement dit, l'hôpital, pour remplir sa mission de « ramener à la norme (guérir) » (Moriau 2005, p. 14), attend du patient une conformité à la fois explicite, par exemple le respect des horaires et des prescriptions médicales, et implicite, comme la coopération ou la ponctualité. Lorsque l'attitude d'un patient s'écarte de ces attentes, l'institution a tendance à lui attribuer une étiquette négative. C'est ce que Vega (2001, p. 77) nomme les « mauvais malades », ceux qui s'éloignent des « habitudes de soins » institutionnelles. Ainsi, l'institution hospitalière, dans sa volonté de garantir une efficacité thérapeutique et organisationnelle, est un « lieu de normalisation » qui tend à marginaliser les patients dont les comportements ne suivent pas ses règles établies (p. 75). Dans cette perspective, l'hôpital contribue à l'émergence de la notion de « patient indésirable ».

Vega continue dans ce sens en précisant que cette exigence institutionnelle de conformité est l'adaptation obligée de l'hôpital « à un modèle biomédical dominant » (p. 75). Selon Meurant, un modèle de santé est « une façon de se représenter les phénomènes : un ensemble de convictions, de croyances, de pratiques et de postulats partagés par un ensemble de praticiens » (2018, p.29). Blois-Da Conceição décrit le modèle biomédical de la santé comme une approche qui conçoit la maladie « comme ayant une étiologie biologique objectivement identifiable (virus, bactéries, facteurs environnementaux, dérèglement hormonal, etc.) et sous la

dépendance de mécanismes internes dont le contrôle échappe à l'individu » (2016, p. 29). Elle précise également que ce modèle « se focalise sur la maladie et non sur le malade » et « accentue le pouvoir des professionnels de santé en encourageant le patient à adopter une position passive » (p. 30).

Autrement dit, le système hospitalier, par son organisation même, privilégie d'après Vega et Blois-Da Conceição une vision de la santé qui se définit par des paramètres essentiellement biologiques et par une dynamique de soin qui inscrit le patient en situation de soumission face à l'expertise médicale.

À ce stade de ma réflexion, je me demande quelle est la place de l'infirmier dans ce modèle biomédical et dans cette dynamique de soin. En effet, les infirmiers s'appuient eux aussi sur des modèles, c'est-à-dire des paradigmes ou « grands courants de pensée », qui façonnent une manière spécifique de concevoir la santé, l'interaction avec le patient et leur propre rôle dans le soin (Pepin et al., 2010, p. 27).

Kérouac et al. (2003, p.6) identifient trois grands paradigmes infirmiers :

- **Le paradigme de la catégorisation**, fondé sur l'approche biomédicale, où la santé est définie objectivement et où le patient est censé adhérer au traitement prescrit.
- **Le paradigme de l'intégration**, qui valorise davantage la relation interpersonnelle et l'adaptation aux besoins spécifiques du patient.
- **Le paradigme de la transformation**, qui considère la santé comme une construction subjective, influencée par les expériences de vie et les choix personnels du patient.

À la lecture de ces auteurs, je constate que le modèle biomédical correspond précisément à ce que la pensée infirmière appelle le « paradigme de la catégorisation ». Selon Pepin et al. (2010, p. 38), ce paradigme, dominant entre 1900 et 1950, repose sur une approche scientifique où « l'absence de maladie et l'éradication des maladies transmissibles » constituent les objectifs centraux des soins. Dans ce cadre, « le rôle infirmier est d'identifier et de corriger les causes, c'est-à-dire les facteurs qui provoquent un mauvais état de santé » (Lecordier, 2011, p. 82). Les soins sont alors standardisés, guidés par des protocoles et centrés sur une logique du « faire pour » (Pepin et al., 2010, p. 38). Le patient, considéré comme « dépendant des soins infirmiers », est attendu dans une posture de coopération avec le soignant pour retrouver la santé (p. 38).

C'est à ce stade de mon analyse que je prends conscience que les réactions observées chez les infirmiers dans mes deux premiers constats, face à monsieur R. et madame H., sont fortement ancrées dans le paradigme de la catégorisation. Ce paradigme reflète également la conception asymétrique de la relation soignant-soigné décrite par Parsons, où le soignant détient le savoir face à un patient qui doit se conformer aux recommandations pour guérir. Il évoque également la relation de soins, telle que décrite par Formarier, fondée sur des attentes normées envers le patient pour garantir l'efficacité des échanges. Comme le souligne Lecordier (2011, p. 82), dans ce paradigme, le sens que l'infirmier donne à sa rencontre avec le patient est celui d'« identifier et corriger » ce qui fait obstacle à la santé. En examinant mes constats sous cet angle, il apparaît clairement que les infirmiers considèrent que monsieur R. et madame H. ne se conforment pas aux comportements attendus pour favoriser leur rétablissement.

Sous ce paradigme de la catégorisation, la tendance à considérer certains patients comme « indésirables » apparaît d'autant plus marquée lorsqu'ils sont perçus comme responsables de leur maladie ou peu coopérants. Cette perspective fait écho à l'approche sociologique développée par Talcott Parsons à la même époque (1951). Selon lui, la maladie représente une forme de déviance qui menace le bon fonctionnement de la société. Le système de soins sert alors de mécanisme pour permettre au malade de retrouver la santé et ainsi rétablir l'équilibre social menacé. D'après Parsons (1975, p. 259), être « malade » confère un privilège : celui d'être temporairement dispensé « des responsabilités sociales normales ». Toutefois, ce privilège n'est accordé que si le patient est un « bon malade », c'est-à-dire s'il respecte deux critères :

- il ne doit pas être jugé responsable de sa maladie
- il doit coopérer pour retrouver la santé, notamment en suivant les recommandations médicales

Or, les patients de mes deux premiers constats, monsieur R. et madame H., ne remplissent aucun de ces deux critères : non seulement ils sont perçus comme responsables de leur état (consommation d'alcool et de tabac pour monsieur R., refus de rééducation pour madame H.), mais ils ne suivent pas non plus les consignes de l'équipe soignante et les recommandations médicales.

À l'inverse, dans mon troisième constat, monsieur B., hospitalisé en psychiatrie, satisfait au premier critère du « bon malade » selon Parsons, puisqu'il ne peut pas être tenu responsable de sa schizophrénie. Néanmoins, il ne correspond pas au second : il rejette les recommandations

médicales en refusant un soin essentiel : son injection d'antipsychotique. Selon la théorie de Parsons, il ne devrait donc pas être considéré comme un « bon malade ». Pourtant, l'équipe en psychiatrie ne modifie ni son attitude ni la qualité des soins qu'elle dispense à Monsieur B. après son refus de traitement. Cette différence significative dans l'attitude des infirmiers met en évidence que l'élément causal n'est définitivement pas le comportement du patient lui-même, puisque monsieur R. et madame H. ont une attitude similaire, mais plutôt la manière dont les soignants perçoivent et interprètent ce comportement.

En analysant cette différence d'attitude des infirmiers sous l'angle des paradigmes infirmiers, je remarque que la réaction de l'équipe en psychiatrie envers monsieur B. ne correspond pas au paradigme de la catégorisation. Elle ne s'inscrit pas non plus dans le paradigme de l'intégration, selon lequel « la pratique infirmière vise le maintien de la santé de la personne dans toutes ses dimensions : santé physique, mentale et sociale » (Pepin et al., 2010, p. 40). Dans ce paradigme, la pratique infirmière s'inscrit dans une perspective où « la santé est un idéal à atteindre » et où l'infirmier cherche à amener le patient à adhérer à la norme médicale en l'aidant « à choisir les comportements relatifs à la santé les mieux adaptés » (p.41).

En psychiatrie, l'équipe a adopté une posture fondamentalement différente qui évoque davantage le paradigme de la transformation. Dans cette approche, la santé est envisagée comme « une valeur et une expérience vécues selon la perspective de chacun » (p.44). Le refus de monsieur B. n'est pas interprété comme une rupture de la relation thérapeutique asymétrique telle que conceptualisée par Parsons, ni comme un manquement aux « comportements attendus » dans la relation de soins décrits par Formarier. Au contraire, les infirmiers reconnaissent le comportement de monsieur B. comme l'expression légitime de sa participation active dans la définition de son propre bien-être, « selon sa vision de la santé » (p.43). Dans ce paradigme, l'infirmier transforme le sens habituel donné à la relation soignant-soigné : il n'agit plus seulement « pour » le patient mais « avec » lui (p. 43), « l'accompagnement et l'empathie » devenant « les maîtres mots de l'infirmière dans le respect du cheminement de son client » (Lecordier, 2011, p.85), lequel peut diverger des protocoles hospitaliers conventionnels. Le paradigme de la transformation propose ainsi de dépasser la dichotomie « santé/maladie » ou « bon patient/mauvais patient » pour se recentrer sur ce qui fait sens pour l'individu, reconnaissant que la santé inclut des dimensions existentielles, personnelles et subjectives au-delà de la simple absence de maladie.

Appliquée à mes constats de stage, cette réflexion met en évidence la difficulté à donner un sens commun, c'est-à-dire créer une relation entre un soignant et un patient lorsque leurs conceptions de la santé et des soins divergent, autrement dit lorsqu'ils évoluent dans des paradigmes différents. Dans mes deux premiers constats, monsieur R. et madame H. adoptent une vision transformatrice : ils ne perçoivent pas leurs comportements comme des « défaillances » à corriger, mais comme des choix de vie légitimes. Monsieur R. considère ainsi que sa consommation d'alcool et de tabac fait partie intégrante de son mode de vie, tandis que madame H. estime mériter de se reposer et privilégie son confort immédiat à la rééducation post-opératoire. Leur perception de la santé inclut des dimensions subjectives et existentielles qui échappent aux critères du modèle biomédical et au paradigme de la catégorisation dans lesquels semblent évoluer les soignants qu'ils rencontrent. Ces derniers, centrés sur la correction des pathologies, perçoivent alors les refus et les exigences de ces patients comme « inadéquats », voire « indésirables », car ils perturbent l'organisation biomédicale des soins et s'opposent aux attentes normatives de l'équipe soignante. Le soignant se sent ainsi légitimé à manifester de l'exaspération ou à prioriser d'autres patients jugés « plus conformes » à la logique biomédicale dominante.

Ainsi, la notion d'indésirabilité d'un patient semble directement liée au paradigme à partir duquel l'infirmier construit le sens de sa rencontre avec le patient, autrement dit, à la manière dont il conçoit la santé, le soin, et son propre rôle dans la relation soignant-soigné.

Monsieur R. et madame H. ont été hospitalisés dans des services généraux tandis que monsieur B. a été hospitalisé dans un service psychiatrique. Le contraste dans leur prise en charge peut-il suggérer que le contexte hospitalier oriente la posture des soignants ? En effet, les différences observées entre les services suggèrent que l'hôpital général, souvent axé sur l'efficience et la standardisation des soins, semble favoriser une approche biomédicale et catégorisante où le patient est évalué selon sa conformité aux normes établies. À l'inverse, les services hospitaliers psychiatriques semblent disposer d'un cadre permettant une approche plus individualisée et transformative du soin.

Je me pose dès lors la question : dans quelle mesure le contexte hospitalier influence-t-il le paradigme sur lequel l'infirmier base ses soins ?

2.2. Analyse de l'article probant

Afin d'explorer la littérature existante en lien avec ma question, j'ai utilisé le moteur de recherche Google Scholar. Pour lancer ma recherche, j'ai sélectionné « recherche avancée » et saisi les mots-clés « paradigme », « soins infirmiers » et « hôpital » dans le champ « trouver un article avec tous les mots ». L'opérateur booléen que j'ai utilisé est « ET » (AND), car j'ai saisi les trois mots dans le champ de recherche qui permet de trouver les articles contenant les trois termes. J'ai défini la langue de recherche en français afin de cibler exclusivement les publications rédigées dans cette langue. Mon objectif était en effet de trouver, si possible, un article provenant de Belgique, car je considère que les réponses provenant de pays anglophones ou du Canada pourraient être moins pertinentes en raison des différences significatives dans les systèmes d'enseignement et les structures hospitalières. J'ai également appliqué un filtre de date, limitant la recherche aux publications parues entre 2015 et 2025, afin de m'assurer d'obtenir des résultats récents.

Ma recherche a généré 9440 résultats. Mon attention a immédiatement été attirée par un titre en huitième position sur la première page : « Panorama des modèles de soins infirmiers (MSI) utilisés par les chefs de département infirmier dans les hôpitaux belges francophones et bilingues ». Cet article a été rédigé par neuf auteurs, tous infirmiers de formation. Deux auteurs sont mis en avant en raison de leur statut académique et de leur contribution scientifique : Dan Lecocq, doctorant en santé publique et maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles, affilié au Centre de recherche en économie de la santé, gestion des institutions de soins et sciences infirmières, et Hélène Lefebvre, professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Les sept autres auteurs sont tous affiliés à l'École de santé publique de l'Université libre de Bruxelles. Parmi eux, deux sont étudiants en master de santé publique : Lucie Bachelet, également enseignante, et Daniel Martin. Deux autres sont enseignants et titulaires d'un master en santé publique : David Dyikpanu et Damien Siddu. Ouassinia Berrabah, également titulaire d'un master en santé publique, n'exerce pas de fonction d'enseignement. Enfin, deux maîtres de conférences complètent l'équipe : Yves Mengal, également doctorant en santé publique, et Magali Pirson, docteure en santé publique et chargée de cours, tous deux rattachés au même centre de recherche que Dan Lecocq.

J'ai retenu cet article car il explore une problématique qui fait écho aux interrogations soulevées à ce stade de mon travail et qui est pertinente pour nourrir ma réflexion sur l'influence du contexte hospitalier sur le paradigme de soins dans lequel évoluent les infirmiers : les chefs de département infirmier fondent-ils leur vision et leur gestion des soins sur un modèle infirmier ? Pour répondre à leur interrogation, les auteurs ont mené une recherche quantitative à visée descriptive et corrélationnelle entre fin 2014 et début 2015, ciblant tous les chefs de département infirmier des hôpitaux belges francophones et bilingues. Sur « 82 répondants potentiels », « 78 ont effectivement participé à l'enquête téléphonique, soit un taux de réponse de 97,5 % » (Lecoq et al., 2017, p. 32). À partir de deux questions principales, portant sur l'existence et la communication d'un modèle de soins infirmiers, et complétées par des données relatives à l'ancienneté, à la formation des répondants et au type d'établissement, ils ont dressé un « panorama des modèles de soins infirmiers utilisés dans les hôpitaux belges francophones » (p. 29). L'étude présente donc un intérêt géographique important, car elle offre une perspective directement liée au contexte hospitalier belge, dans lequel s'inscrivent mes propres observations de stage.

Je reste toutefois consciente des limites de cet article pour mon TFE. Tout d'abord, il a été publié en 2017, soit il y a cinq ans et l'enquête de terrain a été réalisée 3 ans plus tôt, c'est à dire entre fin 2014 et début 2015. Des évolutions ont eu lieu depuis, notamment avec l'introduction d'un master en sciences infirmières en 2020. Cependant, cette période reste relativement courte pour que ces changements aient pu transformer en profondeur les paradigmes dominants dans la pratique hospitalière quotidienne. Deuxièmement, l'objectif des auteurs est sensiblement différent du mien. Leur recherche s'inscrit dans une perspective de gestion, visant à déterminer si les chefs de département infirmier « intègrent une conception infirmière dans la politique de leur département » (Lecoq et al., 2017, p. 28). Mon travail, quant à lui, se concentre davantage sur l'impact que ces choix de modèles de soins ont au niveau de la pratique clinique quotidienne et sur la relation soignant-patient. Enfin, l'article n'aborde pas directement les paradigmes mais les modèles de soins infirmiers. Toutefois, les auteurs établissent clairement que chaque modèle de soins infirmiers s'inscrit dans un paradigme spécifique, comme l'illustre leur classification méthodique selon les paradigmes reconnus (p.39). Cette articulation me permet de transposer les modèles aux paradigmes qui sont au cœur de mon TFE.

Dans leur article, Lecocq et al. soulignent tout d'abord l'importance de l'utilisation d'un modèle de soins infirmiers car il « contribue à affirmer la singularité de la profession infirmière et son émancipation progressive, tant dans les milieux cliniques que dans les milieux académiques » (p. 28). Selon eux, « un modèle de soins infirmiers définit le cadre et structure la pratique infirmière. Il imprime une ligne de conduite spécifique pour l'utilisation d'une démarche scientifique de soins » (p. 30). Les auteurs citent également Hewison, qui explique que fonder une politique de soins infirmiers sur un modèle permet d'éviter de « se retrouver en position de suiveurs et d'accepter les priorités formulées par d'autres » (Hewison, cité par Lecocq et al., 2017, p. 30). Or, le premier résultat marquant de l'enquête réside dans la proportion relativement faible de chefs de département infirmier s'appuyant explicitement sur un modèle conceptuel : « seuls 38 % (...) déclarent qu'un modèle de soins infirmiers sous-tend leur politique » (p. 39). Autrement dit, en 2014, 62 % des chefs de département infirmier dans les hôpitaux belges francophones et bilingues n'adoptent pas explicitement de modèle de soins infirmiers pour diriger leur service.

Dans le cadre de mon TFE, ces données sont importantes car elles laissent supposer que l'influence du modèle biomédical est significatif dans les services qui ne basent pas explicitement leur politique sur un modèle de soins infirmiers. Le modèle biomédical centré sur la maladie, le contrôle des variables biologiques et la conformité du patient à des protocoles standardisés s'accompagne d'attentes normatives fortes auxquelles les patients sont censés se plier. Les soignants, sans autre modèle de soins, pourraient adopter alors, sans nécessairement le nommer, ce qui s'assimile à un « paradigme de la catégorisation ». Dans un tel contexte, un patient dont les choix de vie, les demandes ou les refus de soins perturbent l'organisation du service peut vite se voir étiqueté comme « moins coopérant », « moins méritant ». C'est précisément ainsi que se construit l'« indésirabilité » : le décalage perçu entre les comportements du patient et les attentes normatives des infirmiers.

Parmi les 30 chefs de département infirmier qui déclarent se référer à un modèle de soins, 23 citent celui de Henderson, présenté comme « le premier modèle de soins infirmiers contemporain, développé dans les années 1950 » (p. 38). Issu de l'école des besoins, ce modèle présente une particularité intéressante: il peut s'inscrire tant dans le « paradigme de la catégorisation » (Jovic et al., 2015, p.13) que dans celui de « l'intégration » (Lecocq et al., 2017, p.29), selon son interprétation et son application concrète.

Selon les auteurs, la prédominance du modèle d'Henderson s'explique en partie par l'influence directe de la formation initiale. En effet, comme le soulignent Lecocq et al., « le choix d'un

modèle de soins infirmiers spécifique semble être associé à la Haute École où le chef de département infirmier a effectué ses études », si bien que « les chefs de département infirmier issus d'une même Haute École utilisent le même modèle » (p.35). Ainsi, les chefs de département infirmier diplômés des Hautes Écoles officielles (publiques) utilisent tous le modèle d'Henderson (p.35).

Si je reprends mon expérience personnelle à la HERS, même si nos cours théoriques présentent les différents paradigmes et plusieurs modèles de soins, c'est le modèle d'Henderson qui structure réellement nos prises en charge lors des stages et qui s'impose comme référence théorique dans l'enseignement clinique. Au terme de mes études, c'est donc ce modèle que je maîtrise et que je sentirais le plus légitime à appliquer.

L'enquête révèle également que le choix d'un modèle de soins infirmiers dépend de sa compatibilité avec le contexte institutionnel hospitalier, il s'effectue souvent « en adéquation avec les valeurs professionnelles et les pratiques courantes de l'organisation » (Amar & Guegen, 2007, cité dans Lecocq et al., 2017, p. 31). Cette information souligne l'influence déterminante du contexte hospitalier dans la sélection et l'application concrète du modèle de soins infirmiers. Autrement dit, même si la formation initiale pose les bases théoriques en faveur de l'adoption d'un modèle spécifique, c'est l'environnement hospitalier, à travers ses pratiques quotidiennes, ses normes et ses attentes implicites, qui en renforce ou en freine réellement l'adoption sur le terrain. L'enquête révèle ainsi que « les deux hôpitaux qui utilisent le modèle de soins infirmiers de Watson sont des institutions psychiatriques » (p.38). Les modèles de soins infirmiers issus du paradigme de la transformation sont donc rarement choisis, sauf en psychiatrie, où le modèle de Henderson est « adéquat pour aborder les aspects somatiques de la personne soignée, mais insatisfaisant pour considérer les aspects relationnels, d'où l'utilisation du caring de Watson » (p.40).

Les résultats de Lecocq et al. indiquent que la majorité des services hospitaliers généraux n'adoptent pas explicitement de modèle de soins infirmiers ou se réfèrent au modèle d'Henderson. Les seuls chefs de département infirmier qui déclarent utiliser un modèle issu du paradigme de transformation, le modèle de Watson, sont des services psychiatriques. Cette distinction rejoint mes observations de stage concernant les attitudes différentes des infirmiers en services généraux et en psychiatrie, ainsi qu'aux paradigmes distincts dans lesquels ils semblent évoluer, notamment face aux patients qui ne suivent pas les recommandations médicales ou qui perturbent l'organisation du service.

2.3. Enquête exploratoire

L'analyse de l'article de Lecocq et al. (2017) m'a permis de comprendre dans quelle mesure le contexte hospitalier et la formation initiale influencent concrètement le choix et l'application des modèles de soins infirmiers, eux-mêmes ancrés dans des paradigmes spécifiques. Il a également mis en avant que la présence d'un modèle de soins infirmiers explicite au sein d'un service hospitalier en Belgique restait encore minoritaire en 2014, avec seulement 38% des services concernés (p.28). Toutefois, l'article se concentre principalement sur une perspective managériale, centrée sur les chefs de département infirmier, et non directement sur la pratique quotidienne des infirmiers. C'est pourquoi il me paraît maintenant pertinent d'aller interroger directement des infirmières travaillant dans une structure hospitalière afin de recueillir des observations et des témoignages concrets qui viendront enrichir mon analyse de la présence des paradigmes de soin dans la pratique quotidienne et dans la construction du « patient indésirable ».

J'ai décidé d'interroger deux infirmières aux profils distincts : l'une exerçant en service général (gériatrie) et l'autre en psychiatrie. Ce choix est directement motivé par mes constats de stage et par l'enquête de Lecocq et al. (2017). En effet, comme mentionné précédemment, parmi les 30 chefs de département infirmier qui déclarent explicitement se référer à un modèle de soins, les auteurs ont constaté une division significative selon le type d'institution : les deux seuls hôpitaux utilisant le modèle de Watson (relevant du paradigme de la transformation) sont des établissements psychiatriques, tandis que 23 autres services, principalement généraux, se réfèrent au modèle d'Henderson (p.38).

Mon enquête exploratoire vise deux objectifs principaux : d'abord, constater si ces deux infirmières ont conscience d'adopter dans leur pratique quotidienne une certaine « philosophie de soin », c'est-à-dire un paradigme ou un modèle théorique qui s'y rattache. Ensuite, je souhaite interroger les infirmières sur les situations impliquant des patients qui ne respectent pas les recommandations ou dont l'attitude et les comportements perturbent l'organisation du service. Ces situations sont particulièrement révélatrices car elles mettent en lumière les valeurs implicites ou explicites qui fondent la relation de soin. C'est souvent dans ces moments de « friction » entre les normes portées par le soignant et les choix du patient que le paradigme infirmier adopté se révèle avec le plus de clarté, et que peut émerger la figure du « patient indésirable ».

Les infirmières que j'ai rencontrées ont chacune une dizaine d'années d'expérience. L'une travaille en gériatrie depuis le début de sa carrière, l'autre exerce en psychiatrie après avoir débuté en chirurgie générale. J'ai structuré mon entretien autour de cinq questions principales, visant à explorer leur connaissance des paradigmes, leur philosophie de soins et leurs attitudes face aux patients qui s'écartent des recommandations médicales.

Dès ma première question sur la notion de paradigme en soins infirmiers, j'ai constaté que ce concept théorique n'était pas familier aux deux infirmières. L'infirmière en psychiatrie a reconnu vaguement le terme « mais je ne sais pas dire ce que c'est ». Quant à l'infirmière en gériatrie, sa réponse est encore plus explicite : « Paradigme ? Cela ne me dit rien du tout ».

À la question sur l'application d'une « philosophie de soins » particulière dans leur pratique quotidienne, leurs réponses diffèrent significativement. L'infirmière en gériatrie fait spontanément référence au modèle de Virginia Henderson : « On utilise les 14 besoins pour structurer nos dossiers de soins en gériatrie, c'est la base de toute prise en charge ». Cette observation rejoint les résultats de Lecocq et al. qui identifiaient ce modèle comme le plus répandu dans les services généraux. L'infirmière en psychiatrie, quant à elle, n'évoque pas de modèle de soins spécifique dans sa pratique mais plutôt des outils qu'elle mobilise quotidiennement : « écoute active, pleine conscience, communication non-violente, entretien motivationnel ».

Après leur avoir expliqué le concept de paradigme et les trois grandes approches (catégorisation, intégration, transformation), leurs positionnements respectifs sont apparus clairement différenciés. L'infirmière en psychiatrie s'est immédiatement reconnue dans le paradigme de la transformation : « En psychiatrie, on travaille vraiment avec l'idée que la santé est une expérience propre à chaque personne ». L'infirmière en gériatrie, de son côté, s'est positionnée entre le paradigme de la catégorisation et celui de l'intégration : « on a effectivement une approche assez protocolaire... mais je m'efforce aussi de m'adapter aux besoins spécifiques de chaque personne, même si c'est difficile avec l'organisation du service ».

À la question de savoir si elles s'interrogeaient sur les paradigmes dans leur pratique quotidienne, les deux infirmières ont répondu négativement, mais pour des raisons différentes. L'infirmière en gériatrie a souligné les contraintes pratiques : « Entre les soins, les transmissions, la paperasse, on n'a pas de temps pour ces réflexions théoriques... C'est plutôt lors des réunions d'équipe, quand on a une plainte ou un cas difficile qu'on réfléchit ». L'infirmière en psychiatrie, quant à elle, a expliqué « ne pas réfléchir en terme de paradigme » mais être constamment « en

questionnement sur mon positionnement et mon rôle. Le patient est souvent un miroir et il faut maintenir une bonne réflexion sur sa pratique pour garder une distance juste dans la prise en charge ».

Ces témoignages révèlent que, bien que les infirmières ne formalisent pas leur réflexion en termes de paradigmes, elles sont néanmoins engagées dans une analyse de leur pratique qui, implicitement, interroge les valeurs sous-jacentes à leur approche du soin. La différence entre les deux services est marquante quant à la place accordée à cette réflexion : en psychiatrie, elle semble faire partie intégrante de la culture professionnelle, tandis qu'en gériatrie, elle apparaît plus contrainte par les exigences organisationnelles.

Pour mieux comprendre comment ces paradigmes se manifestent concrètement, j'ai demandé aux infirmières de décrire une situation avec un patient qui ne respectait pas les recommandations médicales ou qui perturbait l'organisation du service.

L'infirmière en psychiatrie a évoqué le cas d'une patiente bipolaire qui réduisait son traitement quand elle sentait venir une phase maniaque légère, car elle appréciait cette énergie créative et cette productivité. Face à cette situation, l'infirmière a décrit une frustration de voir la patiente se mettre en danger, mais elle a adopté une posture d'accompagnement : « Mon rôle n'est pas de lui imposer ce que je pense être le mieux pour elle. Le plus important est de maintenir le dialogue. Il faut prendre en compte sa compréhension de sa maladie, ses stratégies d'adaptation, et ce qui était important pour elle dans sa vie quotidienne. En fait, les adaptations font partie intégrante du quotidien en psychiatrie ». Quand j'ai demandé si sa posture était centrée sur l'état clinique, l'organisation ou le choix du patient, elle a affirmé : « Ma posture était clairement centrée sur le choix de la patiente, tout en gardant à l'esprit la réalité clinique. Pour moi, le respect de l'autonomie et le développement des capacités d'auto-soin sont le plus important ». Cette approche s'inscrit clairement dans le paradigme de la transformation, où la santé est conçue comme « une valeur et une expérience vécues selon la perspective de chacun » (Pepin et al., 2010, p.44). Le refus de traitement n'est pas perçu comme un échec de la prise en charge, mais comme l'expression légitime de ce que le patient considère comme étant bon pour lui. De plus, l'infirmière évoque l'importance de la concertation : « On travaille beaucoup en équipe, si je n'arrive plus à maintenir une approche de non-jugement, ou que je sens que les choses deviennent trop personnelles avec un patient, je l'exprime en réunion et un collègue prend le relais avec le patient le temps que je puisse prendre du recul. »

L'infirmière en gériatrie, quant à elle, a partagé son expérience avec un patient de 84 ans qui refusait son traitement antihypertenseur en raison des effets secondaires, préférant « avoir une

tension un peu plus élevée plutôt que de souffrir de vertige qui l'empêchaient de se sentir bien ». Sa réaction a été marquée par un conflit intérieur entre le respect du choix du patient et la peur du jugement de l'équipe : « Une partie de moi comprenait sa décision mais c'est mal vu quand un patient refuse un traitement... on doit insister, il faut convaincre. Lors des transmissions, lorsqu'un patient refuse un traitement avec une collègue, on entend régulièrement des remarques comme « avec moi, il a pris son médicament sans problème » ou « il suffit de savoir s'y prendre » ». Face à ce type de situation, l'infirmière reconnaît une tension permanente : « C'est difficile de choisir entre le respect du choix du patient et la bonne organisation du service... Je ne veux pas de problème avec les collègues ou avec le médecin. ». Elle a clairement identifié sa pratique dans le paradigme de la catégorisation : « Le patient venait pour aller mieux, on est là pour le soigner ». Ce témoignage illustre parfaitement les tensions inhérentes au paradigme de la catégorisation dominant dans le modèle biomédical. Comme l'explique Vega (2001), l'hôpital est « une institution particulièrement hiérarchisée ... qui véhicule des représentations, des pratiques et des discours médicaux dominants, souvent imposés aux patients » (p.11).

L'élément qui émerge de la réponse de l'infirmière en gériatrie, c'est-à-dire la façon dont le paradigme dominant au sein d'une équipe peut contraindre les pratiques individuelles des infirmiers, m'a surpris lors de l'entretien. Je lui ai alors demandé qu'elle aurait été sa réaction personnelle, sans tenir compte de l'opinion de ses collègues. « Si j'avais été seule à décider, j'aurais probablement respecté son choix et simplement mis en place une surveillance plus rapprochée de sa tension ». La crainte du jugement des collègues et l'idée qu'une « bonne infirmière » doit convaincre le patient de suivre son traitement révèlent l'emprise du modèle biomédical sur la culture institutionnelle. Cette observation est fondamentale : elle suggère que les paradigmes personnels, même lorsqu'ils tendent vers l'intégration ou la transformation, peuvent être neutralisés par le paradigme dominant de l'équipe ou de l'institution. L'infirmière en gériatrie exprime une certaine aspiration vers les autres paradigmes, tout en reconnaissant les contraintes qui la maintiennent dans une approche plus catégorisante. À l'inverse, l'infirmière en psychiatrie bénéficie d'une cohérence entre ses aspirations personnelles et la « philosophie de soins » de son service, ce qui facilite sa pratique. Ces observations rejoignent l'idée développée par Lecocq et al. que le choix d'un modèle de soins infirmiers dépend de sa compatibilité avec le contexte institutionnel et s'effectue souvent « en adéquation avec les valeurs professionnelles et les pratiques courantes de l'organisation » (2017, p. 31).

Enfin, à ma question sur ce que serait pour elles un « patient indésirable », les deux infirmières ont proposé des définitions qui reflètent à nouveau leurs paradigmes respectifs.

L'infirmière en psychiatrie a décrit : « Le patient qui me met le plus en difficulté, c'est celui qui refuse tout lien, toute relation thérapeutique, tout en restant dans une demande de soins ». Cette définition est cohérente avec le paradigme de la transformation, où la relation est l'outil thérapeutique principal. Elle précise cependant : « Mais même dans ces situations, j'essaie de ne pas qualifier le patient d'indésirable. Je m'interroge plutôt sur ce que son refus du lien peut signifier ». L'infirmière en gériatrie a plutôt identifié comme indésirable : « Celui qui, comme Monsieur P., un patient que j'ai actuellement qui refuse systématiquement de suivre son régime diabétique, qui mange des bonbons en cachette et qui a des glycémies incontrôlables. Ce qui me dérange le plus, c'est le sentiment d'impuissance face à quelqu'un qui semble saboter les efforts que nous déployons pour sa santé ». Cette perception est caractéristique du paradigme de la catégorisation, où le patient est attendu dans une posture de coopération avec le soignant pour retrouver la santé (Pepin et al., 2010, p. 38).

L'analyse de ces entretiens confirme et vient compléter plusieurs des hypothèses formulées dans ce travail. Premièrement, les paradigmes infirmiers, bien que méconnus par les deux infirmières, orientent profondément leur approche du soin et leur réaction face aux patients qui s'écartent des recommandations. Deuxièmement, il existe une différence significative entre les services psychiatriques, davantage ancrés dans le paradigme de la transformation, et les services généraux, plus influencés par le paradigme de la catégorisation. Mais l'élément le plus frappant qui émerge de ces entretiens est la façon dont le paradigme dominant au sein d'une équipe peut contraindre les pratiques individuelles des infirmiers. Le témoignage de l'infirmière en gériatrie illustre parfaitement comment, malgré une sensibilité personnelle qui pourrait l'orienter vers une approche plus intégrative, la pression de l'équipe la maintient dans des pratiques plus conformes au paradigme de la catégorisation.

Ainsi, au terme de cette enquête exploratoire, la notion de « patient indésirable » apparaît moins liée au paradigme adopté individuellement par l'infirmier, mais plus fondamentalement au paradigme collectivement validé par l'équipe infirmière et l'institution hospitalière. L'indésirabilité d'un patient semble donc naître d'une construction collective que le leadership infirmier peut déconstruire. Comme le soulignent Lecocq et al., l'adoption explicite d'un modèle de soins « permet de développer l'identité professionnelle des infirmiers » (2017, p.30) en favorisant une vision plus transformative du soin, centrée sur la personne plutôt que sur la conformité au modèle biomédicale et aux attentes institutionnelles.

3. Synthèse, conclusion du travail et pistes de réflexion

Au terme de ce travail, je peux maintenant synthétiser les éléments clés qui ont émergé de mon cheminement et proposer des pistes de réflexion pour la pratique infirmière.

Tout a commencé avec ces trois rencontres en stage : monsieur R. en cardiologie, qui descendait fumer toutes les heures malgré son arythmie, madame H. en orthopédie, qui refusait de marcher après sa prothèse de hanche, et monsieur B. en psychiatrie, qui déclinait son injection d'antipsychotique. Ce qui m'a frappée, c'est la différence de prise en charge par l'équipe infirmière : les deux premiers ont été jugés « moins méritants » et ont reçu des soins de moindre qualité, tandis que le troisième a été respecté dans son choix. Ce contraste m'a poussée à chercher ce qui transforme un patient en « indésirable » aux yeux des soignants.

En me plongeant dans les textes légaux et déontologiques, j'ai constaté que les attitudes que j'avais observées envers monsieur R. et madame H. allaient à l'encontre des principes fondamentaux de notre métier. La loi est claire : chaque patient a droit à des soins de qualité équivalente, sans discrimination liée à son style de vie. Les jugements moraux n'ont pas leur place dans les décisions de soins, qui doivent s'appuyer sur des critères objectifs et scientifiques.

En creusant la notion de « patient indésirable », j'ai fait une découverte importante : ce n'est pas le patient qui est indésirable en soi, mais la relation qui se construit, ou plutôt qui échoue à se construire, entre lui et le soignant. Ce n'est pas tant le comportement du patient qui pose problème, mais la façon dont nous, soignants, le percevons. Et cette perception dépend largement du paradigme de soins dans lequel nous évoluons.

L'étude de Lecocq et al. sur les modèles de soins dans les hôpitaux belges m'a permis de confirmer mes observations : la majorité des services n'ont pas de modèle de soins clairement défini, et ceux qui en ont un se réfèrent généralement au modèle d'Henderson. Seuls les services psychiatriques semblent adopter des modèles plus transformatifs comme celui de Watson. Cela explique en partie pourquoi monsieur B., en psychiatrie, a été accueilli différemment.

Les entretiens que j'ai menés avec deux infirmières ont fait émerger un élément crucial : l'influence de la culture d'équipe. Même si une infirmière aspire personnellement à une prise en charge plus proche des choix du patient concernant sa santé, elle peut être freinée par la pression collective d'une équipe ancrée dans un paradigme plus traditionnel. Ce qui rend un patient

« indésirable » ne dépend donc pas uniquement du paradigme personnel du soignant, mais résulte davantage d'une dynamique collective. La « philosophie de soin » de l'équipe, soutenue par le leadership infirmier, joue ainsi un rôle clé dans la construction ou la déconstruction de l'indésirabilité du patient.

Au terme de cette démarche de mon TFE, je me pose le questionnement professionnel suivant : Quels moyens mettre en place afin que les infirmiers, travaillant dans un service de soins généraux, évitent de construire collectivement la figure du « patient indésirable » et maintiennent une relation de soin respectueuse de l'autonomie et des choix de chaque personne soignée ?

Plusieurs pistes de réponses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, il serait intéressant d'intégrer une véritable réflexion sur la mise en pratique des paradigmes infirmiers dès la formation initiale. Au-delà des concepts théoriques, avoir la possibilité de mettre en pratique différents modèles de soins dans nos prises en charge lors des stages serait une opportunité de comprendre leur influence dans la construction de notre relation avec les patients. Ensuite, nous devrions créer plus d'espaces de parole dans nos équipes, des moments où nous pourrions discuter ouvertement de nos difficultés face aux patients qui défient nos attentes, sans crainte d'être jugés. Plus largement, il serait profitable que chaque service adopte explicitement un modèle de soins infirmiers, pour éviter que la pratique ne soit guidée par défaut par le modèle biomédical encore dominant dans certaines institutions. Sans une évolution collective des modèles de soins, les initiatives individuelles risquent d'être neutralisées par la pression de l'équipe. Ceci rejoint directement l'importance que Lecocq et al. (2017) accordent au choix explicite d'un modèle de soins par les chefs de département.

Ce travail m'a fait comprendre que le phénomène du « patient indésirable » révèle moins un problème avec certains patients qu'une tension dans notre façon même de concevoir le soin. Notre difficulté à accueillir la différence ne vient pas d'un manque de bienveillance, mais de la façon dont nous donnons sens à notre pratique. Le vrai défi n'est pas simplement d'être plus tolérants, mais de transformer notre vision même de la santé, du soin, et de notre rôle. Comme le souligne Lecordier (2011, p. 84) : « L'infirmière possède des connaissances mais se garde bien de détenir la vérité. La représentation de la personne prime, son expérience aussi. »

Il s'agit donc d'une véritable invitation à repenser notre posture professionnelle face à ceux que nous pourrions, trop rapidement, considérer comme des « patients indésirables ».

Conclusion personnelle

Le sujet de mon TFE s'est imposé comme une évidence lors de mon stage en cardiologie, quand j'ai observé ce soupir collectif à l'annonce du retour de monsieur R. Ce moment précis a fait naître en moi un questionnement: pourquoi certains patients suscitent-ils tant d'exaspération chez les soignants ? Cette interrogation s'est renforcée à chaque nouveau stage où je retrouvais ces dynamiques complexes entre soignants et patients jugés « difficiles ». Jusqu'à madame H. où je me suis surprise à partager les jugements de l'équipe.

L'élaboration de ce travail s'est révélée être un véritable défi intellectuel. J'ai navigué à travers une multitude de concepts : la relation de soin, les paradigmes infirmiers, l'équité clinique, le jugement moral... Cherchant sans cesse à tisser des liens entre eux pour comprendre ce phénomène du « patient indésirable ». À plusieurs reprises, je me suis sentie submergée par la complexité de cette réflexion qui touchait à la fois à l'éthique, à la sociologie et à la philosophie du soin.

Pourtant, je ne regrette absolument pas d'avoir choisi ce chemin.

D'un point de vue personnel, ce travail a constitué une véritable opportunité d'introspection, m'invitant à explorer mes propres valeurs, mes attentes et les représentations du type d'infirmière que je souhaitais devenir. J'ai réalisé que l'irritation ou la frustration que j'avais pu ressentir envers madame H. étaient nées d'une vision normative du « bon patient » que j'avais intériorisée sans même m'en apercevoir. Comprendre l'origine de ces émotions m'a permis de prendre du recul et de développer une posture plus réflexive.

Sur un plan professionnel, ce travail m'a permis de prendre conscience de l'importance considérable d'avoir un modèle clair et explicite de soins infirmiers. J'ai pu constater à quel point la présence ou l'absence d'un tel modèle pouvait transformer radicalement la qualité des soins dispensés, et surtout la manière dont nous percevons et prenons en charge nos patients.

Ce TFE marque pour moi le début d'un engagement : celui de cultiver, tout au long de ma carrière, cette conscience du paradigme et du modèle de soins qui sous-tend ma pratique, afin que jamais un patient ne devienne « indésirable » à mes yeux simplement parce qu'il ne correspond pas à mes attentes et à ce que je considère être « bon » pour lui.

Liste de références

- Académie française (s.d.). Indésirable et Patient. Dans Dictionnaire de l'Académie française (9^e édition). Consulté le 11.01.25 sur <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P0971>
- Bachler, L. (2013). Philosophie et psychologie : la question du jugement moral. Dans L. Bègue, C. Blatier, N. Przygodzki-Lionet (dirs.), *Psychologie du jugement moral Textes fondamentaux et concepts*. (pp. 197-227). Dunod.
- Bay, C., Dancot, J., Jacquemin, N., Lebas, M-C., Maucq, S., Pirson, A. et Tison, T. (2020-2021). *Référentiel de compétences professionnelles du Bachelier Infirmier Responsable de Soins Généraux*. Document non publié, Haute Ecole Robert Schuman, Libramont, Belgique.
- Blois-Da Conceição, S. (2016). *Les fondements de la psychologie de la santé*. In Press. Consulté le 05.02.25 sur <https://shs.cairn.info/les-fondements-de-la-psychologie-de-la-sante--9782848353746-page-29?lang=fr>
- Bodenmann, P., Vu, F., Morisod, K. et Jackson, Y. (2023). Équité en santé : un concept souvent galvadé. *Revue Médicale Suisse*, 19 (834), 1294-1297. Consulté le 12.03.25 sur <https://doi.org/10.53738/revmed.2023.19.834.1294>
- Conseil fédéral de l'art infirmier (CFAI). (2017 « mise à jour » 12/01/2018). Code de déontologie des praticiens de l'art infirmier belges. Récupéré du site SPF santé public, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/code_de_deontologie_des_praticiens_ai.pdf
- Fiester, A. (2012). The “Difficult” Patient Reconceived: An Expanded Moral Mandate for Clinical Ethics. *The American Journal of Bioethics*, 12(5), 2-7. Consulté le 11.01.25 sur <https://doi.org/10.1080/15265161.2012.665135>

- Formarier, M. (2007). La relation de soin, concepts et finalités. *Recherche en soins infirmiers*, 89(2), 33-42. Consulté le 12.01.25 sur <https://doi.org/10.3917/rsi.089.0033>
- Kérouac, S., Pepin, J., Ducharme, F. et Major, F. (2003). *La pensée infirmière* (2^{ème} éd.) Beauchemin.
- Larousse. (2022). *Equitable et mauvais*. Dans Le Petit Larousse illustré.
- Laurent F., Laurent S., Lenfant T., Leroy A., Levant E., Mahfoud A. (2005). Les patients non désirés. *Ethica Clinica*, 40(5), 37-44.
- Le Callonnec, A. (2023). La relation de soin comme modèle asymétrique. Dans V.Piccoli, V. Traverso et N. Chambon (dirs.), *L'interprétariat en santé Pratiques et enjeux d'une communication triadique*. (pp.263-268). Presses de Rhizome. Consulté le 10.01.25 sur <https://doi.org/10.3917/chlv.picco.2023.01.0263>.
- Lecocq D, Lefebvre H, Bachelet L, Berrabah O, Dyikpanu D, Martin D, Siddu D, Mengal Y, Pirson M. (2017) Panorama des modèles de soins infirmiers utilisés par les chefs de département infirmier dans les hôpitaux belges francophones et bilingues. *Recherche en soins infirmiers*. 129(6), 27-51.
- Lecordier, D. (2011). La santé et les soins infirmiers : l'évolution de concepts centraux dans un contexte scientifique donné. *Recherche en soins infirmiers*, 106(3), 82-85. Consulté le 07.02.25 sur <https://doi.org/10.3917/rsi.106.0082>
- Jovic, L., Lecordier, D., Poisson, M., Vigil-Ripoche, M., Delon, B., Mottaz, A., Bourkia, D., Joutard, T., & Tenza, M. (2015). L'enseignement des sciences infirmières en France : contenus et stratégies. *Recherche En Soins Infirmiers*, 119(4), 8-40. Consulté le 30.04.25 sur <https://doi.org/10.3917/rsi.119.0008>
- Lochak, D., (1987). Réflexions sur la notion de discrimination, *Droit social*, 11, 1987, p.778.

Loi modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant les dispositions en matière de droits du patient dans d'autres lois en matière de santé du 06 février 2024. (2024). Moniteur Belge, 23 février, p. 26663. Récupéré du site : https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-06-fevrier-2024_n2024001224.html Consulté le 16.11.24

Loi modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, afin d'y insérer la réforme de l'art infirmier et d'y supprimer les Commissions techniques de l'art infirmier et des professions paramédicales et d'y adapter les missions des Conseils fédéraux de l'art infirmier et des professions paramédicales du 18 mai 2024. (2024). Moniteur Belge, 30 mai, p.68211. Récupéré du site : https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-18-mai-2024_n2024005082.html Consulté le 27.11.24

Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé et la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en ce qui concerne la maîtrise de la langue des professionnels des soins de santé du 18 mai 2024 (2024). Moniteur Belge, 31 mai 2024, p.46373. Récupéré du site : https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/05/14_1.pdf Consulté le 02.01.2025

Longneaux, J.-M. (2005). Editorial : les patients indésirables. *Ethica Clinica*, 40(5), 2-3.

Maggiore, R. (2013, 18 décembre). Que vaut un jugement de valeur ? *Libération*. Consulté le 20.10.24 sur https://www.liberation.fr/livres/2013/12/18/que-vaut-un-jugement-de-valeur_967502/?fbclid=IwY2xjawGB6F5leHRuA2FlbQIxMAABHcOhUpHnchdiXIqSevhEmn4nki4j5hBkcFNidFSunK0ay5nkuXNhr_LrQQ_aem_RJCYWq2D7YhkDvZNbohRyQ

Manoukian, A., Massebeuf, A. (2014). *La relation soignant-soigné* (4^e éd.). Édition Lamarre.

Meurant, G., (2018). Clarifier son modèle de santé. *Santé conjugée*, 85 (4), 29-31. Consulté le 21.04.25 sur <https://www.maisonmedicale.org/clarifier-son-modele-de-sante>

- Moriau, J. (2005). Les jeunes « incasables », une construction collective. *Ethica Clinica*, 40(5), 13-18.
- NANDA international (2021). *Diagnostics infirmiers, définitions et classification 2021-2023* (12^{ème} éd., trad. par AFEDI). Elsevier Masson.
- Nitschelm, E. J. (2015). Soignant-soigné, trouver l'accordage pour entrer en résonance. *Jusqu'à la mort accompagner la vie*, 123(4), 47-54. Consulté le 18.01.25 sur <https://doi.org/10.3917/jalmaalv.123.0047>
- O'Dowd, T. C. (1988). Five years of heartsink patients in general practice. *BMJ*, 297(6647), 528-530. Consulté le 11.01.25 sur <https://doi.org/10.1136/bmj.297.6647.528>
- Organisation Mondiale de la Santé. (2020, July 21). *Qualité des soins*. Récupéré du site : Consulté le 18.10.24 sur https://www.who.int/fr/health-topics/quality-of-care#tab=tab_1
- Parsons, T. (1975). The sick role and the role of the physician reconsidered. *The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society*, 53 (3), 257-278. Consulté le 25.01.25 sur <http://www.jstor.org/stable/3349493>
- Pepin, J., Kérouac, S. et Ducharme, F. (2010). *La pensée infirmière* (3^e éd.). Chenelière Education.
- Pierron, J-P. (2007). Une nouvelle figure du patient ? Les transformations contemporaines de la relation de soins. *Sciences sociales et santé*, 25(2), 43-66. Consulté le 15.01.25 sur <https://doi.org/10.1684/sss.2007.0203>
- Serano, C. (2005). Indésirables ou indésirés. *Ethica Clinica*, 40(5), 47-50.
- Vega, A. (2001). *Soignants/Soignés : Pour une approche anthropologique des soins infirmiers*. De Boeck Supérieur.

Je soussigné Valérie Loreaux autorise/~~n'autorise pas~~ (biffer la mention incorrecte) les membres de la Cellule d'Encadrement Méthodologique des Travaux de Fin d'Etudes à utiliser la version électronique de mon Travail de Fin d'Etudes et ce à des fins pédagogiques.

Date et signature(s) (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Lu et approuvé, le 27 mai 2025

